

العلاج بالمعنى

Logotherapy

من تجربة فرانكل إلى التطبيق السريري

ورشة تدريبية للأخصائيين النفسيين — مدة الورشة: ساعتان



"ماذا يبقى للإنسان عندما يُسلب
منه كل شيء تقريبًا؟"



القسم الأول — القصة

قبل أن يصبح العلاج بالمعنى نظرية...

كان فيكتور فرانكل طبيبًا نفسيًا وعصبيًا نمساويًا، مهتمًا منذ وقت مبكر بأسئلة المعنى والمسؤولية والوجود. درس في فيينا، وطور أفكاره في مرحلة مبكرة من مسيرته قبل أن تلتهمها الحرب.

١٩٤٢

الحرب العالمية الثانية

الحرب العالمية الثانية غيّرت حياة فرانكل إلى الأبد. فيينا، التي كانت مركزًا للفكر النفسي، أصبحت تحت الاحتلال النازي، وبدأ عصر من أحلك عصور التاريخ الإنساني.



الاعتقال

المعسكرات

خلال الهولوكوست، اعتُقل فرانكل وأُرسِل إلى عدة معسكرات اعتقال نازية، من بينها أوشفيتز. فقد زوجته وأمه وأخاه في تلك المعسكرات. ظروف لا تُوصف بشكل إنساني.



ما الذي يمكن أن يُسلب من الإنسان؟

الحرية	الأسرة
العمل	الأمان
الممتلكات	الحياة التي عرفها

كل شيء يمكن أن يُسلب... إلا شيء واحد.

"إذا لم تعد تملك السيطرة على ظروفك، فما الذي
يبقى لك؟"

شريحة نقاش — ناقش مع الشخص بجانبك لمدة دقيقة.



المعنى

من تجربته الإنسانية القاسية، أصبح سؤال المعنى محورًا أساسيًا في فكر فرانكل. لاحظ أن الناجين الذين صمدوا كانوا يملكون — في الغالب — شيئًا يعيشون من أجله.

ليس المقصود أن المعاناة جيدة، بل أن الإنسان قد يجد معنى حتى عندما يواجه معاناة لا يستطيع إلغاءها.



مهم جدًا — ما الذي لا يقوله العلاج بالمعنى؟

✗ "فكر بإيجابية"

المعنى ليس إيجابية سطحية. يمكن أن يتعايش مع الألم الحقيقي.

✗ "المعاناة شيء جيد"

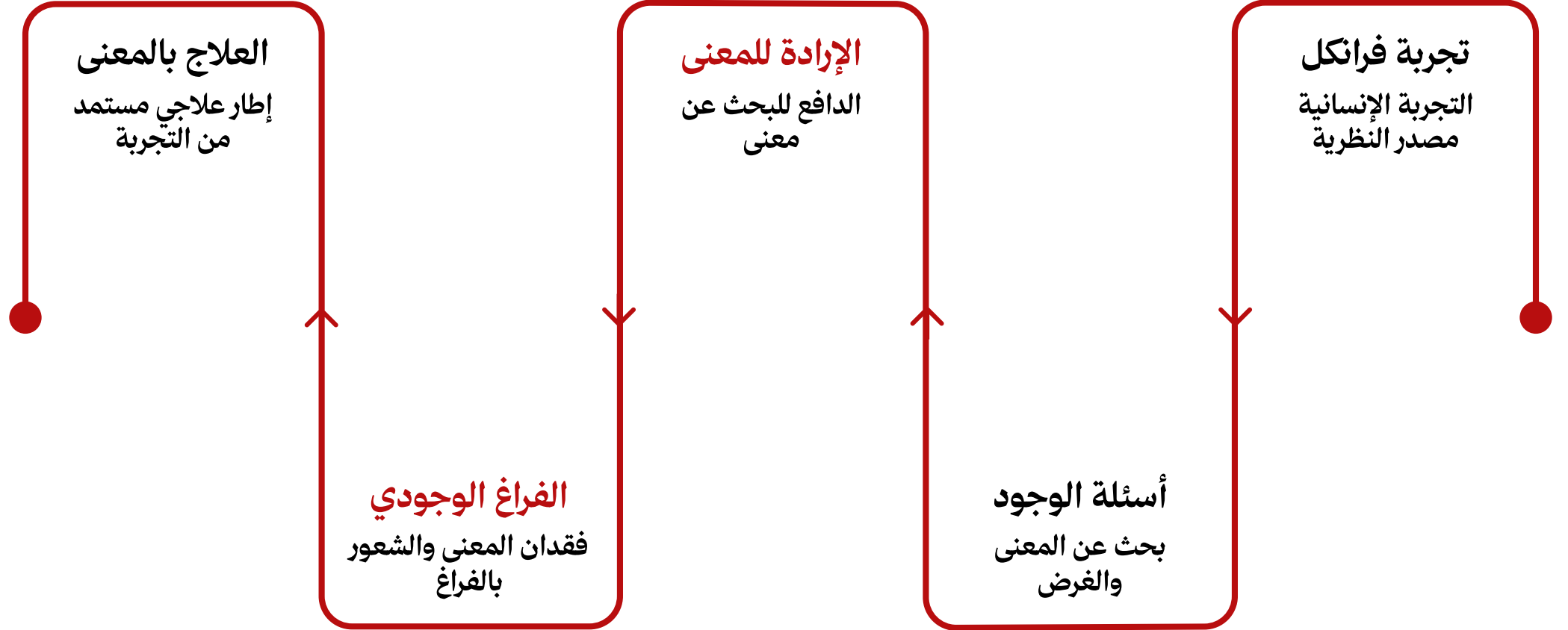
فرانكل لم يمجّد الألم، بل تحدث عن الموقف منه عندما لا يمكن تجنبه.

✗ "كل شيء يحدث لسبب"

هذه ليست فكرة فرانكل. المعاناة لا يلزم أن يكون لها سبب خارجي.

المعنى لا يلغي الألم.

من التجربة إلى النظرية



لم تكن Logotherapy فكرة أكاديمية مجردة. نشأت من داخل تجربة إنسانية حقيقية، ثم تحولت إلى إطار علاجي منظم.

ما هو العلاج بالمعنى؟

هو نهج علاجي طوره فيكتور فرانكل، يضع البحث عن المعنى والمسؤولية والاختيار في قلب العملية العلاجية Logotherapy.

المسؤولية

المعنى لا يُعطى بل يُكتشف، والمراجع مسؤول عن هذا الاكتشاف.

الاختيار دائمًا

حتى في أصعب الظروف، يبقى للإنسان هامش من الاختيار في موقفه.

المعنى أولاً

الدافع الجوهري للإنسان ليس المتعة ولا القوة، بل إيجاد معنى.

WILL TO MEANING

الإرادة للمعنى

الإنسان لا يبحث فقط عن المتعة أو القوة؛ بل لديه حاجة عميقة إلى أن يرى حياته ذات معنى — هذا هو المحرك الأساسي في نظرية فرانكل.

3 أسئلة تساعدك على فهم فرانكل

لماذا يستحق هذا أن أعيشه؟

ما الذي يجعل استمراري في الحياة ذا قيمة بالنسبة لي؟

كيف أعيش؟

هل أسلوبني في الحياة يعكس ما أقدره حقًا؟

ماذا أريد؟

ما الأشياء التي أسعى إليها فعلاً في حياتي؟

هذه أسئلة للاستكشاف في الجلسة، وليست أسئلة لها إجابة جاهزة.

المعنى = السعادة

السعادة

"كيف أشعر؟"

حالة عاطفية مؤقتة، يصعب الإمساك بها مباشرة.

المعنى

"ما الذي يستحق أن أعيش من أجله؟"

توجه عميق لا يتوقف على الحالة المزاجية اللحظية.

يمكن أن أشعر بالألم وأظل أرى معنى لحياتي. والسعادة — بحسب فرانكل — غالبًا ما تأتي نتيجة للمعنى، لا هدفًا بحد ذاتها.

المعنى ليس بالضرورة شيئًا ضخمًا



علاقة إنسانية

طفل، صديق، شريك، أحد يحبه.



مسؤولية أو عمل

ما يقدمه الشخص للعالم من حوله.



قيمة يؤمن بها

مشروع، موقف، شيء يريد أن يكون شاهدًا عليه.



تجربة حياة

لحظة جمال، تجربة فن، لقاء إنساني حقيقي.



هل كل فقدان للمعنى يعني اضطرابًا نفسيًا؟

لا.

ما يقوله فرانكل

فقدان المعنى هو جزء طبيعي من الأزمات الوجودية الإنسانية. ليس كل شعور بالفراغ تشخيصًا نفسيًا.

الصورة السريرية

قد يتداخل فقدان المعنى مع الاكتئاب والقلق والفقد والأزمات الوجودية — لكنه بحد ذاته ليس تشخيصًا مستقلًا في DSM أو ICD.

القسم الثالث — الفراغ الوجودي

الفراغ الوجودي

Existential Vacuum

شعور بالفراغ أو غياب الاتجاه أو عدم وجود شيء يبدو جديرًا بأن يُعاش من أجله — حتى في غياب أي أزمة خارجية واضحة.

وصفه فرانكل بأنه ظاهرة منتشرة في العصر الحديث، حيث فقد الإنسان كثيرًا من الأطر التقليدية التي كانت تمنحه الاتجاه.

كيف يتكلم المراجع عن الفراغ الوجودي؟

"ما أدري وش أبي."

"طيب وبعدين؟"

"كل شيء صار بلا قيمة."

"ما عندي شيء أنتظره."

"أنا عايش لأن المفروض أعيش."

هذه جمل تستحق التوقف عندها — وراءها أسئلة سريرية مهمة.

استمع لما وراء الجملة

"بعد ما فقدت وظيفتي، ما عاد لي قيمة."

الكلمة الظاهرة

الوظيفة — وكأن المشكلة هي فقدان العمل فقط.

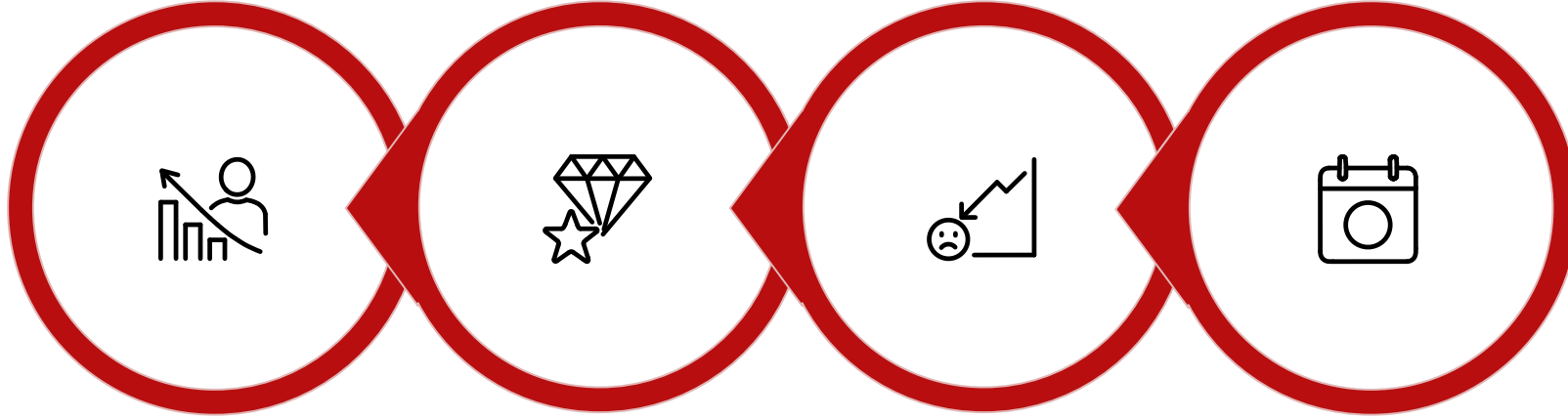
السؤال السريري

"ماذا كانت الوظيفة تمثل لك؟"

هنا نبدأ نفهم القيمة الحقيقية التي تأثرت.

الفقدان الظاهر هو الحدث. الفقدان الحقيقي هو ما كان الحدث يحققه من قيمة أو هوية أو انتماء.

من الحدث إلى المعنى



كيف يعيشها
الآن؟

ما القيمة خلفه؟

ما الذي فُقد؟

الحدث

هذا المخطط يمثل مسار التفكير السريري في العلاج بالمعنى — من الحدث الخارجي إلى استكشاف البعد الداخلي.



القسم الرابع — مصادر المعنى

من أين يأتي المعنى؟

1

ما أقدمه للحياة

المعنى من خلال الإنتاج والعطاء والمسؤولية.

2

ما أستقبله من الحياة

المعنى من خلال ما أختبره وأعيشه وأشعر به.

3

الموقف الذي أتخذه

المعنى من خلال كيفية مواجهتي لما لا أستطيع تغييره.

١ — القيم الإبداعية

المعنى من خلال ما أقدمه — Creative Values

المساعدة والمسؤولية



رعاية شخص آخر، القيام بدور مهني، تحمّل مسؤولية ذات قيمة.

الإبداع والإنتاج



العمل الفني، الكتابة، الاختراع، أي شيء يضيفه الشخص للعالم.

مثال سريري: "أنا أعمل لأن عملي يجعلني أشعر أنني أضيف شيئاً." — هنا المعنى من خلال ما يقدمه.

٢ — القيم التجريبية

المعنى من خلال ما أُختبره — Experiential Values

التجارب الإنسانية

لقاءات حقيقية، لحظات حضور، تجارب
تترك أثراً.



الجمال والطبيعة

تجربة الفن، الطبيعة، الموسيقى — أي
شيء يلمس فيه شيء أكبر منا.



الحب والعلاقات

تجربة الارتباط العميق بشخص آخر — يراه
فرانكل أحد أرقى أشكال المعنى.



٣ — قيم الموقف

المعنى من خلال الموقف — Attitudinal Values

"عندما لا أستطيع تغيير الواقع، قد يبقى لي مجال لاختيار موقفي تجاهه."

كيف أعيش؟



مرض مزمن

هذا لا يعني الرضا القسري أو التجاهل، بل هو اختيار واعٍ للموقف الوجودي رغم الظرف الصعب.

متى نعمل على التغيير؟ ومتى نستكشف الموقف؟

إذا كان غير قابل للتغيير

→ نستكشف الموقف والمعنى الممكن داخل هذا الواقع.

هنا تبرز قيم الموقف — Attitudinal Values.

إذا كان الشيء قابلاً للتغيير

→ نعمل معًا على تغييره.

هنا يأتي دور حل المشكلات، التدخل السلوكي، والتخطيط.



لا نتسرع في تصنيف الشيء "غير قابل للتغيير" — هذا تقييم سريري يتطلب استكشافًا حقيقيًا.

لا تبدأ بـ: "ما معنى حياتك؟"

✓ ابدأ من حياته نفسها

اسأل عن لحظات، أشخاص، مواقف، ما يهمه في يومه.
المعنى يظهر في التفاصيل، لا في الإجابات الكبيرة.

✗ السؤال الذي يُجمّد المراجع

"ما هو معنى حياتك؟"

هذا السؤال غالبًا يُشعر المراجع بالضغط أو الإحراج.

أسئلة تساعدك على اكتشاف المعنى

القيم

"ما الأشياء التي تهلك فعلاً؟" — "متى تشعر أنك أنت؟"

العلاقات

"من الأشخاص المهمون لك؟" — "ما الدور الذي تحب أن تلعبه في حياتهم؟"

الماضي

"ما الذي كان يعطي حياتك قيمة قبل هذه الأزمة؟"

المستقبل

"إذا تحسنت، ما الشيء الذي تتمنى أن تعود إليه؟"

لا تكتفِ بالإجابة الأولى

→ المراجع: "أطفالي."

→ المعالج: "وش اللي يجعل أطفالك مهمين بالنسبة لك؟"

→ المراجع: "أبي أكون أبًا جيدًا."

→ المعالج: "وش معنى أن تكون أبًا جيدًا بالنسبة لك؟"

المسؤولية

الحب

العطاء

الحضور

تنبيه: المعالج لا يقرر المعنى، بل يستكشفه مع المراجع.

اسمع القيمة خلف المشكلة

القيمة المحتملة	ما يقوله المراجع
العطاء / الكفاءة / المسؤولية	"فقدت وظيفتي"
الحب / الانتماء / المشاركة	"انتهت علاقتي"
الاستقلالية / الدور / الكرامة	"مرضت"



نكتب "القيمة المحتملة" وليس "المعنى الحقيقي" — لأن التفسير يجب أن يأتي من المراجع دائمًا.

تمرين ١

ماذا تسمع؟

العبارة الأولى

"أنا فاشل لأنني فقدت وظيفتي."

العبارة الثانية

"بعد الطلاق ما عاد لي قيمة."

العبارة الثالثة

"من يوم مرضت وأنا عبء."

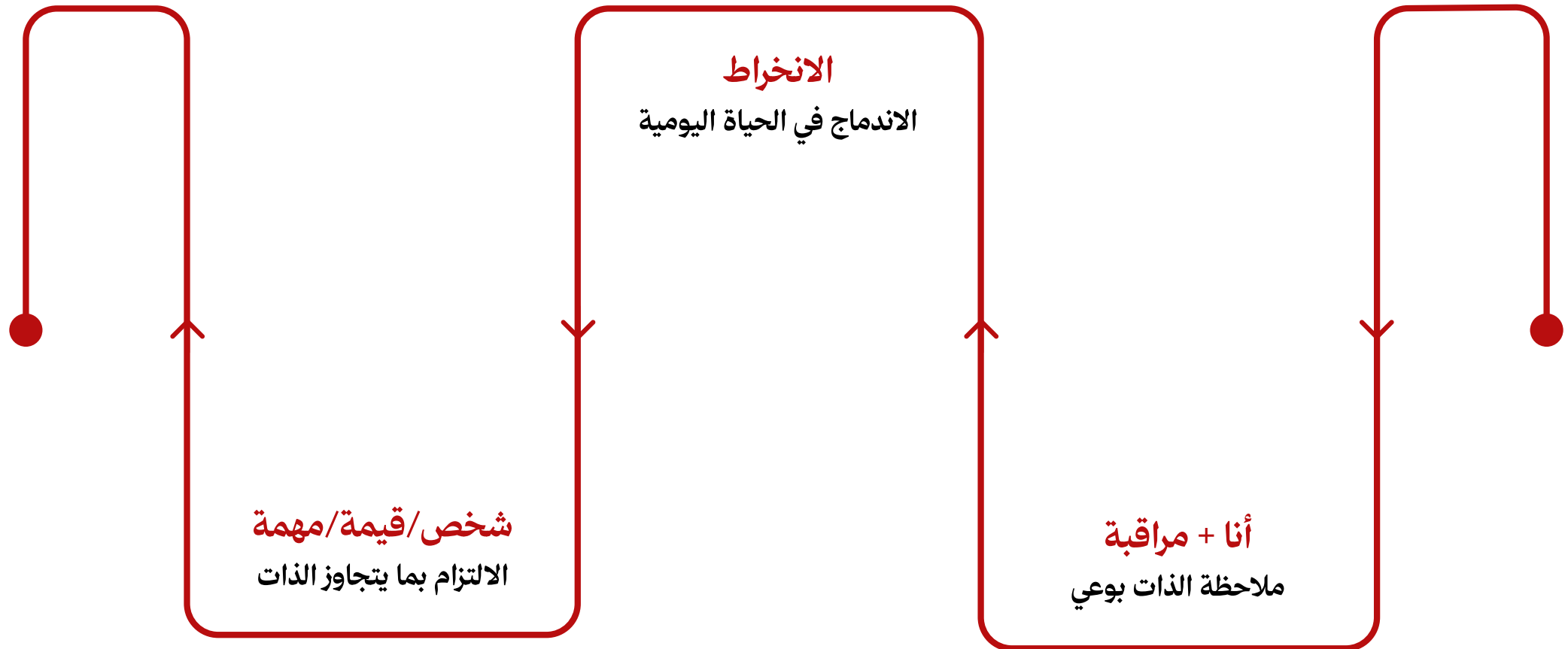


المطلوب: ما القيمة المحتملة خلف كل عبارة؟ وما السؤال الذي ستطرحه للتأكد؟

تجاوز الذات

Self-Transcendence

المعنى لا يأتي دائمًا من التركيز على الذات، بل قد يظهر عندما يتجه الإنسان نحو شخص أو قيمة أو مسؤولية تتجاوز اهتمامه بنفسه.



متى يصبح التركيز على الذات جزءًا من المشكلة؟

"هل أنا قلق؟"

"هل تحسنت؟"

"هل أشعر بالسعادة؟"

"هل لاحظوا توتري؟"

ماذا لو أصبح هدفنا ليس مراقبة الحياة، بل العودة إلى عيشها؟

3 فنيات نحتاج أن نعرفها

Socratic Dialogue

الحوار السقراطي — أسئلة لاستكشاف القيم
والافتراضات

Dereflection

إعادة التوجيه — تحويل الانتباه من الذات إلى الحياة

Paradoxical Intention

النية المتناقضة — كسر دائرة الخوف والترقب

سنتناول كل فنية بالتفصيل مع أمثلة سريرية.

الحوار السقراطي — Socratic Dialogue

استخدام أسئلة منظمة تساعد المراجع على اكتشاف قيمه ومعانيه وافتراضاته، بدلاً من أن يتلقاها من المعالج.

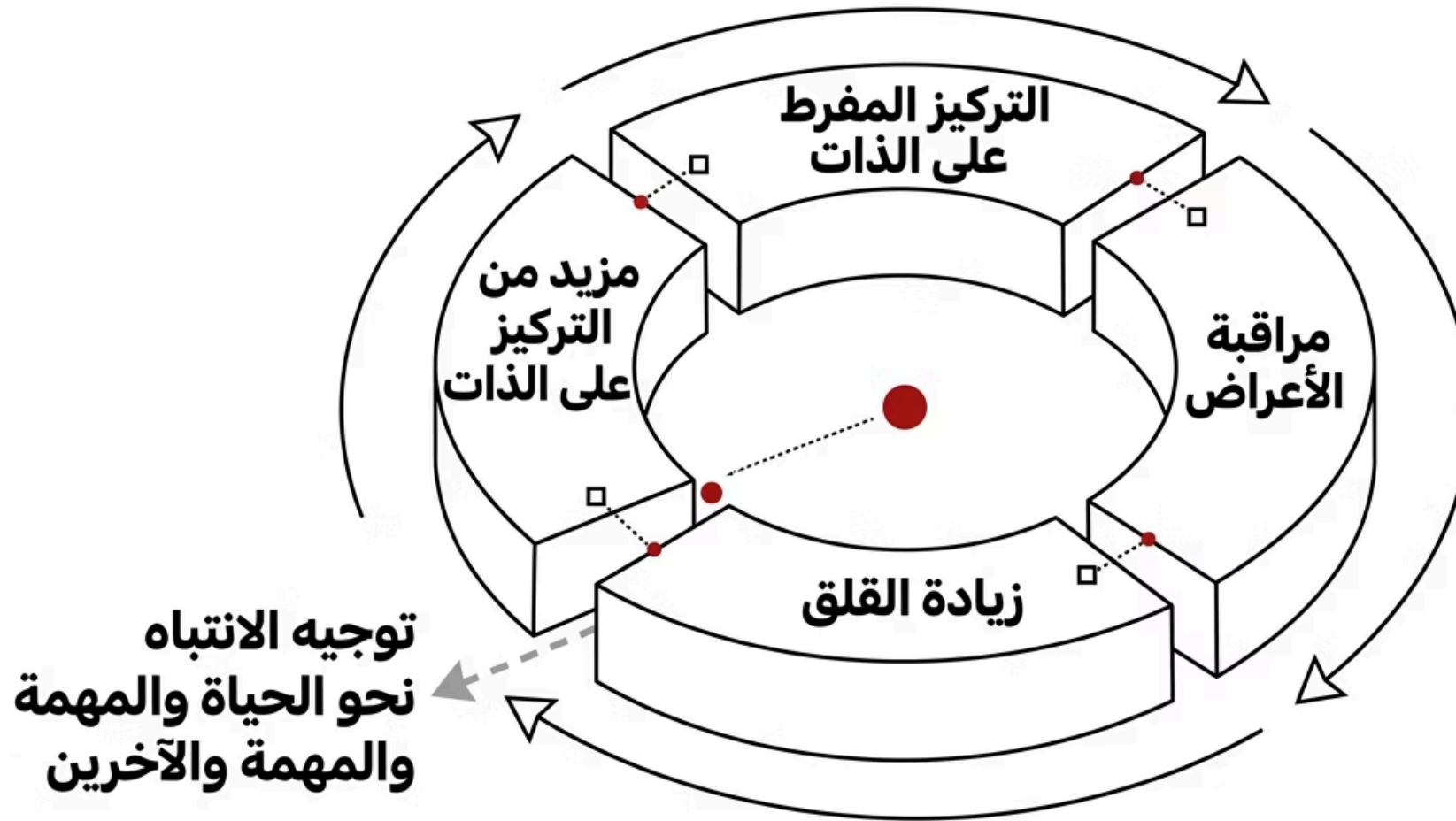
→ المعالج: "ما الذي يجعلك تعرف أنك فاشل؟"

→ المراجع: "أنا فاشل."

→ المعالج: "هل النجاح هو القيمة نفسها أم أنه وسيلة لشيء أهم؟"

→ المعالج: "من أين جاء هذا المعيار؟"

إعادة التوجيه — Dereflection



لا تعني إنكار الأعراض — بل تعني توجيه الانتباه نحو شيء يهم المراجع فعلاً خارج دائرة مراقبة الذات Dereflection.

مثال على Dereflection

"كل ما أدخل مجلس أفكر: هل صوتي يرتجف؟ هل شكلي غبي؟ هل لاحظوا توتري؟"

السؤال العلاجي

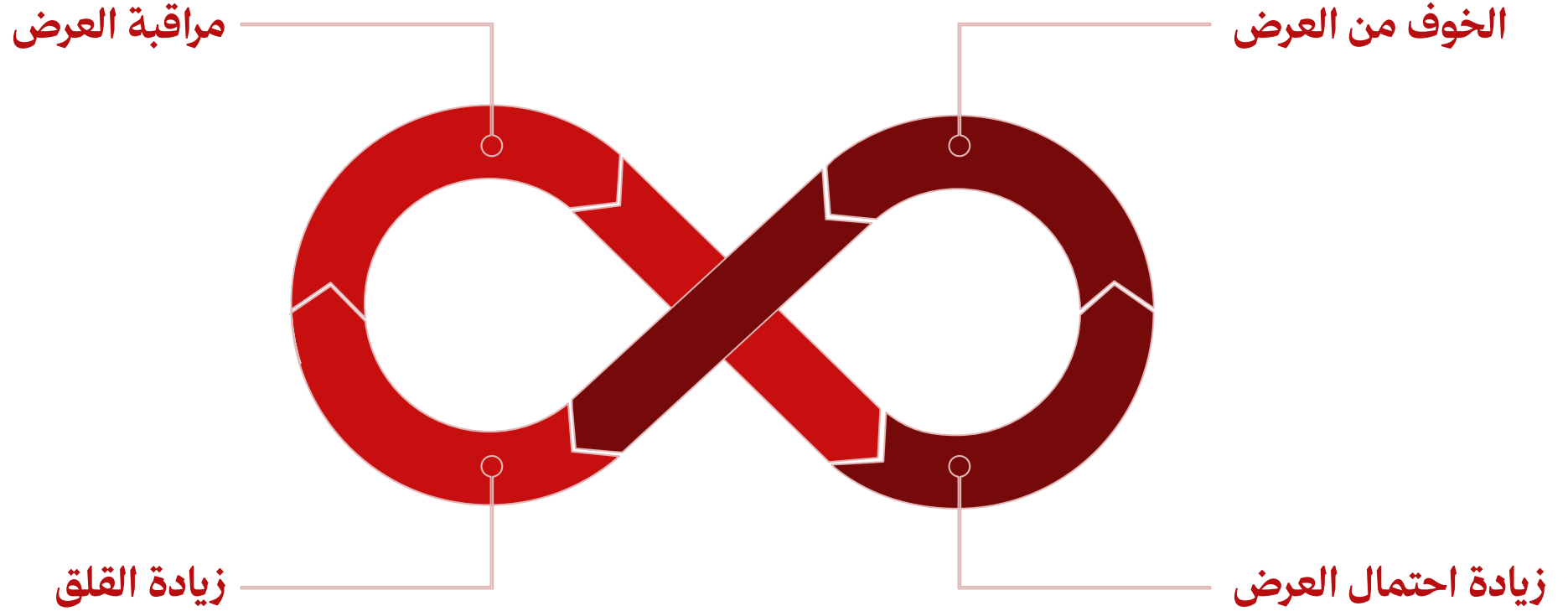
"لو لم تكن مشغولاً بمراقبة نفسك، ما الشيء الذي كنت تريد أن تفعله أو تقوله في هذا المجلس؟"

الأسلوب الذي نتجنبه

"حاول ألا تفكر في التوتر."

← هذا يزيد التركيز على المشكلة.

Paradoxical Intention — النية المتناقضة



فكرة فرانكل: الإنسان الذي يحاول بشدة ألا يحدث شيء معين غالبًا يزيد احتمال حدوثه — خاصة في القلق والوسواس.

مثال — Paradoxical Intention

مراجع يخاف من التلعثم في عرض تقديمي.

✓ التوجه العلاجي

صياغة تساعد على مواجهة احتمال التلعثم دون الدخول في معركة قهرية لمنعه —
بأسلوب خفيف ومدروس.

✗ النهج الذي يعزز المشكلة

"يجب ألا أتلعثم."

← المراقبة المستمرة تزيد الاحتمال.



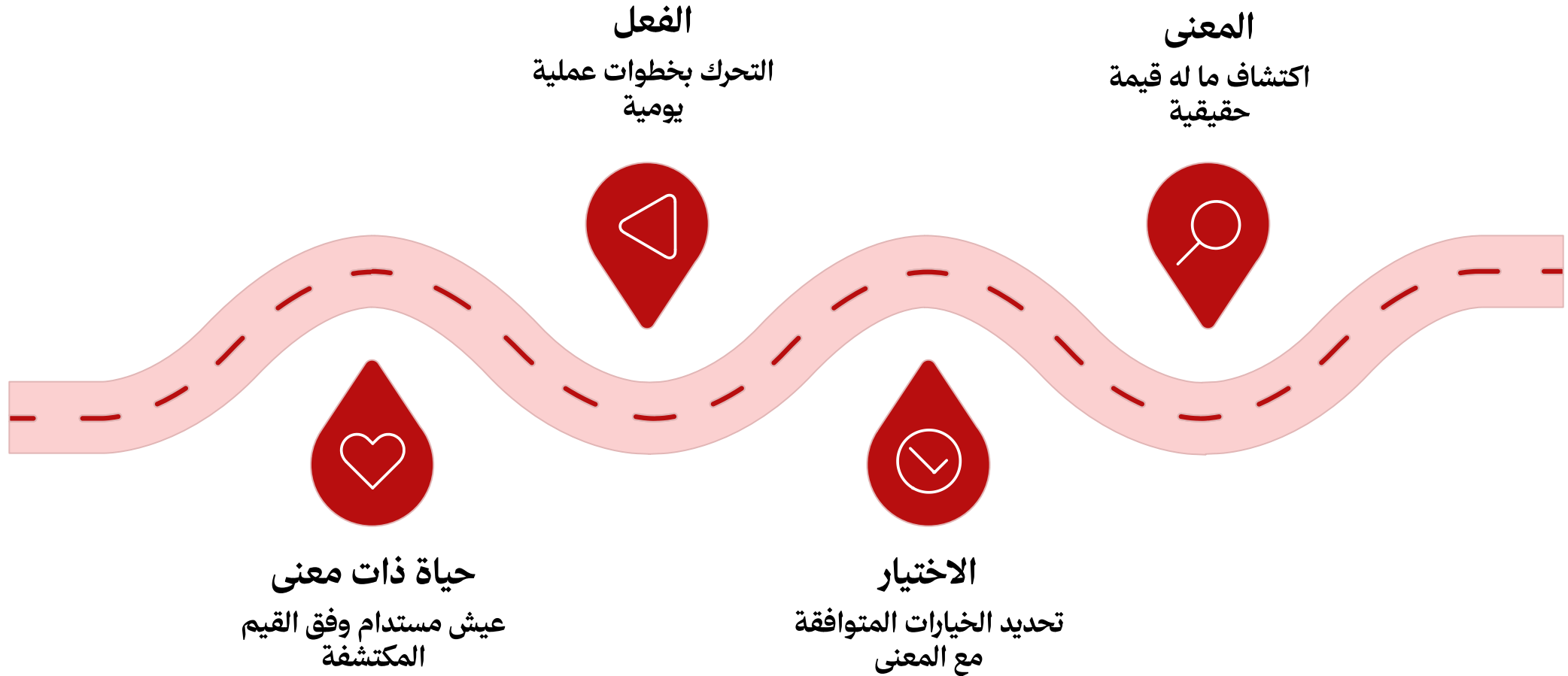
هذه الفنية تحتاج صياغة سريرية دقيقة، ولا تُطبَّق بشكل آلي على كل حالة أو كل اضطراب.

متى أستخدم كل فنية؟

الفنية	الحالة المناسبة
Socratic Dialogue	اكتشاف القيم والمعنى، إعادة فحص الافتراضات، استكشاف الهوية
Dereflection	الانشغال المفرط بالذات، مراقبة الأعراض، القلق الاجتماعي
Paradoxical Intention	الخوف والترقب من عرض معين، القلق المرتبط بالأداء، بعض حالات الأرق

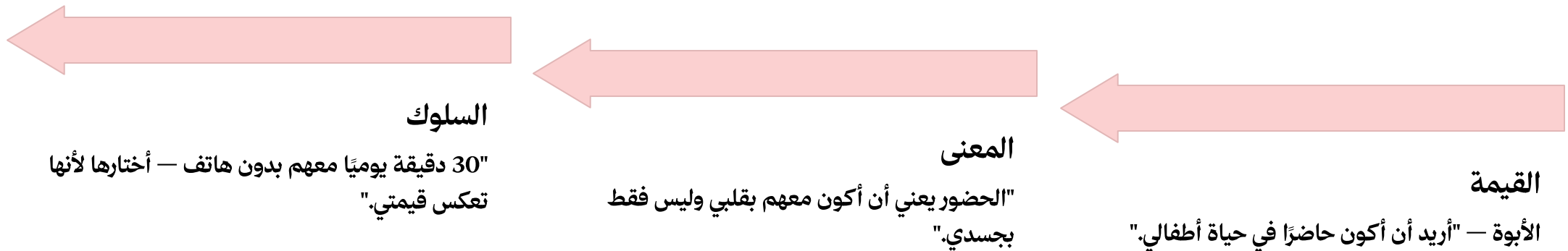
المعنى وحده لا يكفي

إذا اكتشفنا معنى مهمًا ولم يتغير شيء في الحياة، بقي المعنى مجرد فكرة.



الهدف النهائي ليس الوصول إلى إجابة فلسفية، بل مساعدة المراجع على أن يعيش وفق ما يجده ذا قيمة.

مثال — من المعنى إلى السلوك



الهدف ليس أن يصبح المعنى "واجبًا"، بل أن يتحول إلى سلوك يختاره المراجع لأنه يتوافق مع قيمته.

من المعنى إلى التدخل

"مراجع فقد وظيفته ويقول: أنا ما عدت أحس أن لي قيمة."

1

ما الذي قد يكون فقدته؟

2

ما القيمة المحتملة؟

3

ما السؤال التالي؟

4

ما السلوك الذي يمكن أن يجسد هذه القيمة؟

القسم التاسع — الحالات السريرية

العيادة المصغرة الآن أنت المعالج.

سيتم تقسيم المجموعة إلى فرق — كل فريق يتعامل مع حالة سريرية ويناقش أسئلة محددة.



"أنا ما عاد أبي أموت، لكن ما عاد أشوف سبب أعيش. حتى لو تحسنت، وش الفائدة؟"

ما أولويتك السريرية؟

تقييم الخطر أولاً — ثم استكشاف المعنى في السياق المناسب.

ما الذي لا يجب أن تفترضه؟

لا تفترض أن فقدان المعنى هو السبب الوحيد لما يعيشه.

ما الذي ستستكشفه؟

ما القيم والعلاقات والأشياء التي لا تزال موجودة في حياته؟

"بعد ما تركتني، ما عاد لي أي قيمة."

ما الذي فقدته فعلاً؟

هل فقدت شخصاً؟ هوية؟ دوراً؟ انتماءً؟

ما القيمة التي كانت العلاقة تحققها؟

الحب؟ الانتماء؟ الشعور بأنه مرئي ومهم؟

ما السؤال الذي ستطرحه؟

ابداً من ما كانت تعطيه العلاقة، لا من العلاقة نفسها.

"من يوم مرضت وأنا عبء على أهلي."

ما يمكن وما لا يمكن

ما الذي يمكن تغييره في وضعه؟ وما الذي لا يمكن؟ هنا تأتي قيم الموقف —
Attitudinal Values

ما يمكن استكشافه

ما مصدر المعنى المتأثر؟ الاستقلالية؟ الدور؟ الكرامة؟ ما الذي لا يزال موجودًا رغم المرض؟

"أنا لا أستطيع الاستمتاع بأي مجلس؛ كل تفكيري في كيف يراني الناس."

ما الشيء الذي تعيد توجيه انتباهه إليه؟
ما الذي يريد فعله في المجلس أصلاً لو لم يكن
مشغولاً بالمراقبة؟

كيف ستشرحها؟
بلغة بسيطة، دون مصطلحات تقنية، تناسب المراجع.

هل Dereflection مناسبة؟
قيم: هل الانشغال بالذات هو المحور الرئيسي
لمعاناته؟

"حققت كل شيء كنت أريده، لكنني ما زلت أشعر أن حياتي فارغة."

هدف مقابل معنى

الوصول إلى الهدف لا يضمن المعنى. قد يكون الهدف صحيحًا، لكن ما يقود إليه قد يكون غير متوافق مع قيمه العميقة.

ما الذي ستستكشفه؟

هل حقق ما يريده فعلاً؟ أم ما كان يُتوقع منه؟ ما الفرق بين ما يريده وما يراه ذا قيمة حقيقية؟

عندما يقول المراجع:
"ما عاد أبي أعيش..."

المعنى ليس بديلاً عن السلامة

تقييم الخطر

إجراءات السلامة

التدخل السريري

العمل على المعنى



في وجود خطر انتحاري: الأولوية هي تقييم الخطر وإجراءات السلامة والتدخل السريري المناسب. العمل على المعنى لا يأتي إلا في السياق الآمن.

بعد تأمين السلامة...

أسئلة يمكن أن تساعد في فهم المعنى وعوامل الحماية:

الأمل الممكن

"وش الشيء الذي لو عاد إلى حياتك قد يجعل الاستمرار أكثر احتمالاً؟"

الروابط الإنسانية

"من الشخص الذي لا تزال علاقتك به مهمة بالنسبة لك؟"

عوامل الصمود

"وش الشيء الذي خلاك تستمر إلى الآن رغم معاناتك؟"



هذه الأسئلة جزء من الاستكشاف السريري — وليست بديلاً عن تقييم الانتحار أو بروتوكولات السلامة.

ليس كل شيء مشكلة معنى

اضطرابات استخدام المواد

اضطراب ذهاني

اكتئاب شديد

اضطرابات قلق شديدة

أزمات انتحارية

قد يكون المعنى جزءًا من الصياغة السريرية، لكنه ليس بالضرورة التدخل الرئيسي أو الوحيد. العلاج المبني على الدليل يأتي أولاً.

لا تحوّل العلاج بالمعنى إلى...

✗ امتنان إجباري

"الحمد لله، الوضع يمكن أن يكون أسوأ."

✗ إيجابية سامة

"انظر للجانب المشرق!"

✗ تجاهل البيولوجي والاجتماعي

المعنى لا يلغي العوامل النفسية والعضوية والبيئية.

✗ وعظ

فرض قيم المعالج وإجابته على المراجع.

المعالج القائم على المعنى لا يعطي إجابات — بل يفتح أسئلة.



Meaning-Oriented Formulation

نموذج الصياغة القائمة على المعنى

01	ما الذي فقدته المراجع؟ الحدث والفقْد الظاهر والفقْد الحقيقي.	02	ما الذي لا يزال مهمًّا؟ ما تبقى من قيم، علاقات، أشياء تهمه.	03	ما مصدر المعنى؟ Creative / Experiential / Attitudinal
04	ما السؤال الذي أحتاج أن أطرحه؟ السؤال الذي يساعده على الاستكشاف.	05	ما الخطوة التي تجسّد هذا المعنى؟ سلوك صغير، مختار، متوافق مع قيمته.		

5 أسئلة خذها معك للعيادة

1 ما الذي فقدته هذا الشخص؟

2 ماذا كان يعطي حياته قيمة؟

3 ما الذي لا يزال مهمًا؟

4 ما الذي يستطيع اختياره رغم ظروفه؟

5 ما الخطوة الصغيرة التي تجسّد هذا المعنى؟

الخلاصة

"لا أعطي المراجع معنى حياته."

أساعده على اكتشاف ما يجعل حياته ذات قيمة بالنسبة له، ثم مساعدته على أن يعيش وفق هذا المعنى
— خطوة صغيرة في كل مرة.



المراجع الأساسية

التطبيق السريري

Wong, P. T. P. (2014). The Human Quest for Meaning (2nd ed.). Routledge.

Batthyány, A., & Russo-Netzer, P. (Eds.). (2014). Meaning in Positive and Existential Psychology. Springer.

Logotherapy — مراجع حديثة

Breitbart, W. et al. (2012). Meaning-centered psychotherapy. Journal of Clinical Oncology.

Längle, A. (2005). The search for meaning in life. Existential Analysis.

فرانكل — المصدر الأصلي

Frankl, V. E. (1963). Man's Search for Meaning. Beacon Press.

Frankl, V. E. (1986). The Doctor and the Soul. Vintage Books.

Frankl, V. E. (1988). The Will to Meaning. Meridian.

شكرًا لكم

العلاج بالمعنى لا يبدأ بإعطاء إجابة...
بل بطرح السؤال الذي يساعد الإنسان على اكتشاف إجابته.

محمد القحطاني

